

아급성 갑상선염, 이해하고 끝까지 치료하기

바이러스 감염 후 갑상선에 생기는 통증성 염증 — 4단계 자연경과와 단계별 치료법을
알아봅니다

아급성 갑상선염 (Subacute Thyroiditis, de Quervain's)

바이러스 감염 후 2~8주 뒤 발생하는 자기 한정적 갑상선 염증 — 성인 갑상선 통증의 가장 흔한 원인



환자가 경부 통증을 경험



30~50세 여성에게 호발



12~18개월 내 완전 회복

감기 등 바이러스 감염 후 2~8주 뒤 갑상선에 염증이 시작됩니다. 여름~초가을(엔테로바이러스 유행기)에 더 흔하며, 대부분 자기 한정적이지만 5~15%에서 영구적 갑상선기능저하증이 남을 수 있어 적절한 치료와 경과 관찰이 필요합니다.

왜 생길까요? — 바이러스 감염이 방아쇠

바이러스가 직접 갑상선을 공격하거나, 면역 반응이 과도하게 활성화되어 갑상선 세포가 파괴됩니다

감기 등 바이러스 감염 후 2~8주 뒤에 갑상선에 통증과 염증이 시작됩니다.

콕사키 바이러스(Coxsackie), 아데노바이러스, 볼거리 바이러스(mumps), EBV, 코로나19 등 다양한 바이러스가 원인이 됩니다. 바이러스가 갑상선 여포 세포를 직접 손상시키거나, 면역 반응이 과도하게 활성화되어 여포가 파괴됩니다. 파괴된 세포에서 저장돼 있던 갑상선 호르몬이 한꺼번에 혈중으로 유출되면서 갑상선중독 증상이 나타납니다.



GENETIC SUSCEPTIBILITY

HLA-B*35 양성

환자의 약 70%에서 이 유전자 표지가 양성 — 가족 중 갑상선 질환력이 있다면 주의가 필요합니다.

SEASONAL PATTERN

여름~초가을

엔테로바이러스 유행기와 일치 — 코로나19 이후 발생 빈도가 증가했다는 보고도 있습니다.

주요 증상 — 4가지 핵심 신호

환자의 96%가 경부 통증을 경험하며, 약 50%에서 갑상선중독 증상이 동반됩니다

SYMPTOM · 01 · 96%

목 앞쪽 통증 (Neck Pain)

갑상선 부위(목 앞쪽)에 심한 통증과 압통. 턱·귀·뒷머리로 방사되며, 한쪽에서 시작해 반대쪽으로 옮겨가기도 합니다. 삼킬 때 통증이 심해질 수 있습니다.

SYMPTOM · 02

발열과 전신 증상 (Fever)

38~40도의 발열, 몸살, 피로감이 동반됩니다. 감기 후에 시작되므로 처음에는 감기가 계속되는 것으로 오해하기 쉽습니다.

SYMPTOM · 03 · 50%

갑상선중독 증상 (Thyrotoxicosis)

갑상선 세포 파괴로 저장된 호르몬이 한꺼번에 유출되어 빈맥(심장 빨리 뛴), 손 떨림, 체중 감소, 더위를 잘 타는 증상이 나타납니다.

SYMPTOM · 04

갑상선 종대 (Goiter)

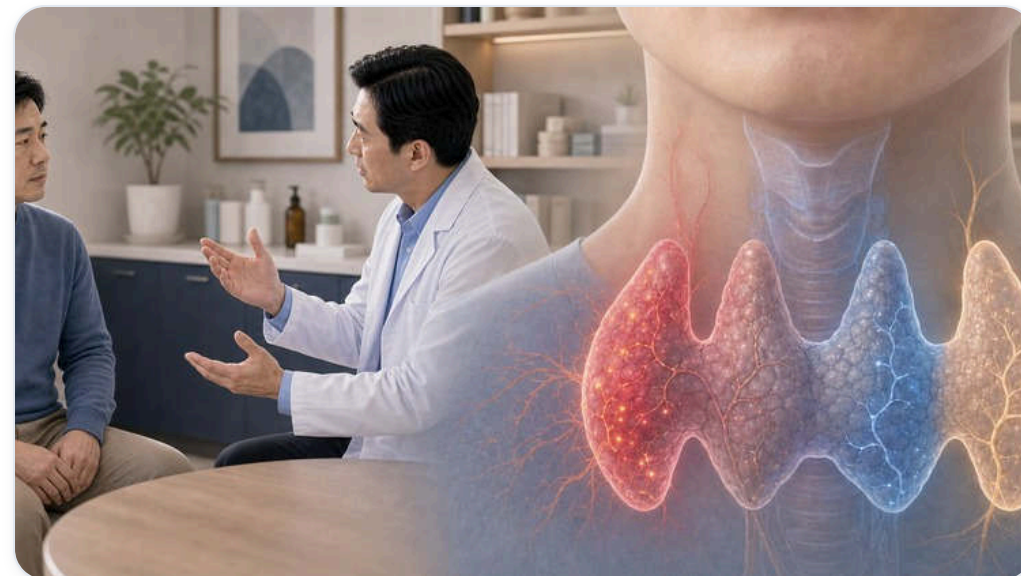
목 앞쪽 갑상선이 커지고 만지면 단단하고 아픕니다. 한쪽 엽이 다른 쪽보다 더 부어 보이기도 합니다. 림프절은 보통 정상입니다.

자연경과 — 4단계 패턴

대부분 6~18개월에 걸쳐 단계적으로 회복됩니다 (Hyperthyroid → Euthyroid → Hypothyroid → Recovery)



참고 3단계를 모두 거치는 환자는 약 30%이며, 중독기만 거치고 바로 회복하는 경우도 많습니다. 영구적 기능저하(5~15%)는 정기 검사로 조기 발견하면 호르몬 보충으로 정상 생활이 가능합니다.



진단은 어떻게 하나요?

혈액검사(ESR/CRP·갑상선 기능)와 영상검사(초음파·RAIU)를 종합하여 진단합니다

LAB · 01

염증 수치 (ESR / CRP)

ESR(적혈구 침강속도) > 50 mm/h로 현저히 상승. CRP(C-반응 단백질)도 크게 상승하여 다른 갑상선 질환과 구별되는 핵심 단서입니다.

LAB · 02

갑상선 기능 (TSH·FT4)

중독기에 TSH 억제, FT4/FT3 상승. TRAb(자가항체) 음성으로 그레이브스병을 배제하고, Anti-TPO도 대개 음성입니다.

IMAGING · 03

방사성요오드 섭취율 (RAIU)

2~5% 미만으로 거의 측정 불가 수준 — 그레이브스병(>35%)과 구별되는 핵심 소견입니다. 갑상선 세포 파괴를 직접 반영합니다.

IMAGING · 04

갑상선 초음파 (Ultrasound)

경계 불명확한 저에코 영역, 도플러상 혈류 감소. 악성종양과 비슷해 보일 수 있어 회복 후 추적 초음파를 권장합니다.



비슷한 질환과 어떻게 구별하나요?

통증 유무·ESR/CRP·RAIU 섭취율이 그레이브스병/하시모토 갑상선염과의 핵심 감별점입니다

! 아급성 갑상선염 (de Quervain's)

- 심한 경부 통증 (96%) — 핵심 단서
- ESR/CRP 현저히 상승
- TRAb 음성 · Anti-TPO 음성
- RAIU 매우 낮음 (< 5%)
- 초음파 혈류 감소
- 치료 — NSAIDs / 스테로이드

+ 그레이브스병 / 하시모토 갑상선염

- + 통증 없음 (Graves'-Hashimoto 모두)
- + ESR/CRP 정상
- + Graves' — TRAb 양성 (~95%)
- + Graves' — RAIU 높음 (> 35%)
- + 초음파 혈류 — Graves'에서 현저히 증가
- + 치료 — 항갑상선제(MMI) 또는 경과 관찰

치료 1단계 — NSAIDs와 베타차단제

경증~중등도는 NSAIDs로 통증을, 베타차단제로 빈맥·손떨림 등 갑상선중독 증상을 조절합니다

DRUG · 01 · 1차 선택

NSAIDs (소염진통제)

이부프로펜 400~800mg 또는 록소프로펜 60mg, 하루 3회. 경증 통증의 1차 약제이며, 위장 보호를 위해 PPI와 병용합니다.

DRUG · 02 · 심장 증상

Propranolol (베타차단제)

프로프라놀롤 10~40mg 하루 3회. 빈맥·손떨림·두근거림을 조절하며, 중독기(2~6주) 동안만 복용합니다. 천식 환자는 다른 약제로 대체.

DRUG · 03 · 위장 보호

PPI (위장약 병용)

NSAIDs 장기 복용 시 위염·위궤양 예방을 위해 오메프라졸·란소프라졸 등을 식전 30분에 함께 복용합니다.

DRUG · 04 · 효과 평가

2~3일 후 재평가

2~3일 복용 후 통증이 호전되지 않으면 스테로이드(프레드니솔론)로 전환합니다. 항갑상선제(MMI/PTU)는 효과가 없습니다.

중요 항갑상선제(메티마졸/PTU)는 사용하지 않습니다 — 호르몬이 새로 합성되는 것이 아니라, 파괴된 세포에서 저장돼 있던 호르몬이 유출되는 것이기 때문입니다.

치료 2단계 — 스테로이드 감량 프로토콜

NSAIDs 효과 부족 시 프레드니솔론 사용 — 천천히 줄여야 재발(약 12%)을 예방할 수 있습니다



감량 원칙 5mg까지 줄이는 데 4주 미만이면 재발 위험이 높아집니다 (비재발군 44.3일 vs 재발군 19.0일). 절대 임의로 중단하지 마세요 — 급격한 중단은 부신 위기를 유발할 수 있습니다.



반드시 즉시 알려야 할 위험 신호

치료 중 다음 증상이 나타나면 처방을 임의로 조절하지 말고 바로 진료를 받으세요



갑상선 폭풍 의심 — 응급 상황

고열(39도 이상)·심한 빈맥(분당 130회 이상)·의식 혼돈·구토가 동반되면 갑상선 폭풍(thyroid storm) 가능성 — 즉시 응급실로 가야 합니다.



스테로이드 임의 중단 시 부신 위기

증상이 좋아졌다고 혼자 판단해 끊으면 부신 위기(심한 저혈압·쇼크) 위험. 반드시 의사 지시에 따라 천천히 감량하세요.



48~72시간 내 통증 호전 없음

스테로이드 복용 후 2~3일 이내에 통증이 뚜렷이 줄지 않으면 진단이 맞는지 재평가가 필요합니다 — 즉시 재진하세요.



영구적 갑상선기능저하증 (5~15%)

회복 후에도 6~12개월간 TSH 정기 검사 필수. 피로·추위 민감·체중 증가가 지속되면 호르몬 보충(레보티록신)이 필요합니다.

오늘 꼭 기억할 핵심 8가지

대부분 완전히 회복됩니다 — 꾸준한 복약·경과 관찰이 회복의 핵심입니다

01 바이러스 감염 후 발생하는 **자기 한정적 질환** — 12~18개월 내 85~95% 완전 회복

02 목 앞쪽 통증이 핵심 증상 — **그레이브스병과 다름** (그레이브스병은 통증 없음)

03 경증 — **NSAIDs(부루펜·록소닌) + PPI(위장약)** 병용

04 빈맥·손떨림 — **프로프라놀롤(인데랄)** 로 조절

05 중등도~중증 — **프레드니솔론 6~8주 단계 감량** (절대 임의 중단 금지)

06 2~3일 내 통증 호전 없으면 **즉시 재진** — 진단 재평가 필요

07 갑상선 기능검사(TSH)를 **6~8주 간격** 정기적으로 받기

08 피로·추위 민감·체중 증가 등 **기능저하 증상** 나타나면 알리기

함께 치료하면 반드시 회복됩니다

궁금한 점이 있으시면 언제든지 상담해 주세요 — 정기 검사로 끝까지 함께하겠습니다

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

HOURS

평일 08:30~18:30
토요일 08:30~13:30



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요